Juliana Kinderziekenhuis

Opnameboekje Neonatologie

De afdeling Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis richt zich op de behandeling en zorg van pasgeboren baby's. Het gaat hierbij niet alleen om te vroeg geboren baby's (prematuren), maar ook om voldragen baby's die na de geboorte problemen of een aangeboren afwijking hebben. Deze brochure bevat informatie over de afdeling waar uw baby wordt verzorgd.

Bezoekregels

Pasgeborenen zijn extra kwetsbaar en gevoelig voor infecties en virussen. Om hen hier zoveel mogelijk hiertegen te beschermen is een aantal regels opgesteld, waaraan u en andere bezoekers zich moeten houden. Daarnaast zijn er regels om de rust en privacy van de baby's en hun ouders te beschermen.

- Ouders zijn 24 uur per dag welkom op de afdeling, één van de ouders kan blijven overnachten. In overleg met de verpleegkundige kan ook een tweede ouder blijven overnachten.
- Eigen broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom. Zij zijn eenmaal per dag welkom tussen 16.00 en 19.00 uur. De kinderen moeten zich wel rustig gedragen en mogen niet heen en weer lopen, of op de gang spelen zonder toezicht.
- Als een broertje of zusje verkouden is of hoest, mag hij/zij niet op bezoek komen. Ook volwassenen die verkouden zijn mogen niet op bezoek komen. Bij twijfel kunt u overleggen met de verpleegkundige van de afdeling.
- Kinderen onder de 16 jaar mogen niet op bezoek komen.
- Vanwege privacy is het niet toegestaan om bij andere baby's langs te gaan.
- We verzoeken u zo min mogelijk te bellen op de kamer. Het signaal dat uw mobiele telefoon uitzendt tijdens bellen of gebeld worden, kan een storing veroorzaken bij de apparatuur rondom uw baby.
- Uw baby is gebaat bij rust op de kamer, houd hier rekening mee als u wel telefoneert.

Vóór u de kamer/zaal ingaat

Naast de bezoekregelings zijn er voor het naar binnen gaan van een kamer/zaal de volgende regels:

- Vanwege de hygiëne moeten sieraden aan polsen of handen, dus ook ringen af. Laat deze niet achter, maar stop ze in uw zak of (hand)tas of laat ze thuis.
- Bij binnenkomst graag de handen wassen met zeep.
- Als u belt om te informeren naar uw baby verzoeken, wij u dit bij voorkeur te doen buiten de verzorgingstijden van uw baby. De verpleegkundige kan uitleggen wanneer dit is.

NB: Laat kostbaarheden en geld nooit onbeheerd achter. Waardevolle bezittingen kunt u overigens beter thuislaten. Het ziekenhuis is ondanks alle voorzorgen niet aansprakelijk voor het verlies van bezittingen.

Uw baby op de Neonatologie afdeling

Uw baby verblijft op de afdeling Neonatologie, omdat hij of zij speciale medische en verpleegkundige zorg nodig heeft. Opname van een baby op deze afdeling is vooral voor de ouders een ingrijpende gebeurtenis en gaat vaak samen met angst en onzekerheid. De medewerkers van de afdeling doen hun best u tijdens deze periode zoveel mogelijk te ondersteunen. Het is ook belangrijk dat u uw vragen stelt. Is iets u niet duidelijk? Leg uw vraag dan voor aan de verpleegkundige die voor uw baby zorgt. Als u een gesprek met de behandelend arts wilt, dan kunt u deze verpleegkundige ook vragen een afspraak te maken met de arts. Het is gebruikelijk dat u 1 keer per week een gesprek met de behandelend arts heeft en waar nodig vaker. Wilt u, wanneer u niet in het ziekenhuis bent, weten hoe het met uw baby gaat? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de afdeling. Het telefoonnummer is (070) 210 7219.

Contact met uw baby

De opname van uw baby kan voor enkele dagen zijn, maar ook voor een paar weken of zelfs maanden. Omdat dit verblijf voor baby én ouders ingrijpend is, is direct contact - ook tijdens deze periode - heel belangrijk. Daarom kunt u zo vaak u wilt bij uw baby zijn. Contact is van belang voor het krijgen van een band met uw baby, maar bijvoorbeeld ook voor de groei en ontwikkeling van uw baby.

Wij vinden het belangrijk dat de baby als eerste contact heeft met ouders, maar dat als ouders het zelf goed vinden dat de baby bij familie op schoot mag, is dat hun keuze, bij broertjes/zusje mag dit wel.

Raak uw baby zo veel als mogelijk aan en praat tegen hem of haar. Misschien vindt u dit in het begin moeilijk, omdat de baby zo kwetsbaar en klein is. Toch zijn uw aanrakingen nodig. Als u dit eerst nog onwennig en moeilijk vindt, kan de verpleegkundige u hierbij uiteraard begeleiden. Wij vinden het niet wenselijk als uw baby door ander bezoek (broertjes en zusjes uitgezonderd) wordt aangeraakt of op schoot wordt genomen.

Als u een knuffel meeneemt voor uw baby, neem dan geen pluche, maar een schone en goed wasbare knuffel mee die niet groter is dan 15 cm. De knuffel wast u wekelijks. Op de afdeling krijgt uw baby een gehaakt inktvisje. Wij vragen u dit bij zichtbare vervuiling of anders 1x per week op 60 graden te wassen met vloeibaar wasmiddel. Daarna in de wasdroger goed uit laten wasemen/dampen en ongeveer 2 dagen laten drogen. Als u geen droger hebt, kan het uitwasemen soms meerdere dagen duren.

Het is belangrijk dat de knuffel helemaal droog is. Het is wenselijk dat er meerdere knuffeltjes zijn, zodat er afgewisseld kan worden.

Als uw kindje te vroeg geboren is, krijgt hij/zij een speen van de afdeling. Als u zelf een speen heeft aangeschaft vragen wij u deze mee te nemen. De speen moet 1x per dag worden uitgekookt; dit kunt u op de afdeling doen in een uitkookzakje. De verpleegkundige kan u uitleggen hoe dit moet. U kunt op www.neomaatje.nl of www.Care4neo.nl ook zelf een speen bestellen. Gebruik van eigen babykleding is welkom. Nieuwe kleding moet wel eerst gewassen worden op 60 graden. Op de afdeling is ook babykleding aanwezig.

NIDCAP: ontwikkelingsgerichte zorg

De baby's op de afdeling worden verzorgd volgens de NIDCAP-methode. Dit staat voor individuele ontwikkelingsgerichte zorg voor pasgeborenen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren zoals licht en geluid op de ontwikkeling van prematuur geboren baby's. De

baby's worden zoveel mogelijk beschermd tegen deze invloeden. Daarbij gebruiken we middelen om de ontwikkeling te bevorderen en stress tegen te gaan. Bij zeer jonge baby's wordt ook het gedrag geobserveerd in combinatie met een persoonlijk zorgplan. Nadere informatie kunt u krijgen bij een van de NIDCAP opgeleide verpleegkundigen op de afdeling.

Met wie krijgt u vooral te maken

Op de afdeling krijgt u te maken met verschillende specialismen. De afdeling heeft vaste kinderartsen (neonatologen) die gespecialiseerd zijn in pasgeborenen, verpleegkundig specialisten, artsen in opleiding tot kinderarts en een groot team kinderverpleegkundigen. Het verpleegkundig team heeft de specialisatie Intensive Care (IC) & High Care (HC) Neonatologie, of wordt daarvoor opgeleid. Ook zijn er stagiaires werkzaam van verschillende verpleegkundige opleidingen, zoals de kraamspecialisatie en opleiding tot kinderverpleegkundige. Uw baby wordt zoveel als mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundigen.

Kinderfysiotherapeut

Het doel van kinderfysiotherapie is om eventuele motorische ontwikkelingsproblemen vroegtijdig in beeld te krijgen. De kinderfysiotherapeut observeert de motoriek van baby's, die bij de geboorte jonger dan 32 weken zijn en van baby's voor wie dit door de kinderarts wordt aangevraagd. Aan de hand van de observaties wordt aan de ouders advies gegeven over de houding en de manier waarop zij de baby het beste kunnen oppakken, dragen en op schoot nemen. De kinderfysiotherapeut kan voor thuis TOP(Fysiotherapie thuis) aanvragen om u verder thuis te begeleiden en zo de ontwikkeling van uw kindje verder te vervolgen.

Ouderbegeleiding/Maatschappelijk werker

Een ouderbegeleider/maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam. Voor problemen en zorgen die te maken hebben met de opname van uw baby, kunt u bij dit teamlid terecht.

Medisch- en zorgdossier

De gegevens over uw baby worden vastgelegd in een medisch- en een zorgdossier. Heeft u vragen over het medisch- of zorgdossier of wilt u het dossier inzien? Dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige en/of behandelend arts van uw baby.

Apparatuur

Vanwege de intensieve zorg wordt op de afdeling veel gebruik gemaakt van bewakingsapparatuur die licht en geluiden voortbrengen. Andere hulpmiddelen, zoals infusen en sondes, zijn bedoeld om de voedings- en lichamelijke toestand van de baby's te verbeteren. We realiseren ons dat het beangstigend kan zijn uw baby te zien in een dergelijke omgeving. Door regelmatig aanwezig te zijn raken de meeste ouders hier snel mee vertrouwd.

Om u enig inzicht te geven in de meest voorkomende apparatuur treft u hieronder een korte beschrijving aan.

Couveuse: de meeste baby's liggen in een couveuse, dit is een doorzichtig overkapt 'bedje'. Hierdoor kunnen we de baby's goed observeren en bewaken. Een couveuse is voorzien van warmte en eventueel bevochtigde lucht. U kunt uw baby gewoon aanraken en ertegen praten. Zodra de toestand

van een baby het toelaat, mag deze uit de couveuse. Dat kan bijvoorbeeld door uw baby bij u op schoot te nemen, of door te buidelen (zie hieronder het stukje ‘Buidelen’).

Er is een mogelijkheid dat uw kindje niet meer de intensieve zorg nodig heeft van de neonatologie en naar unit A of B wordt overgeplaatst. Wij hebben een folder over de overplaatsing. Als u dat wenst kunt u een rondleiding op deze afdeling krijgen.

Monitor: op het lichaam van uw baby kunnen drie plakkers zitten die via snoertjes contact maken met een monitor. Deze registreert de hartslag en de ademhaling. De ademhaling wordt gecontroleerd, omdat te vroeg geboren baby’s kunnen vergeten door te ademen. Hierdoor kan de hartfrequentie zakken. Als dit gebeurt, alarmeert de monitor ons direct. Als dit nodig is sporen wij de baby aan om door te ademen.

Saturatiemeter: op de hand of voet van uw baby kan een zogenoemde sensor met een rood lichtje zijn geplakt. Deze sensor meet de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Zo wordt gecontroleerd of een baby extra zuurstof nodig heeft. Wanneer de baby al zuurstof krijgt, wordt ook de hoeveelheid gecontroleerd.

N.C.P.A.P. is een hulpmiddel bij het ademhalen. Hierbij wordt door een neusstukje lucht in de richting van de longen geblazen. Het stimuleert de ademhaling en houdt de longen goed ontplooid.

Neusbril: Een neusbril is een middel om met behulp van flow (lucht) de ademhaling te stimuleren. De neusbril bestaat uit 2 kleine sprietjes die in de neusgaten worden ingebracht. Er kan ook zuurstof worden toegediend via de neusbril.

Fototherapie: iedere pasgeboren baby kan geel worden als het bilirubinegehalte te hoog is. Bilirubine is een afvalstof die het kind geel maakt. Het gehalte is te bepalen door een beetje bloed af te nemen. Als het gehalte te hoog is, wordt de baby onder een zogenoemde fototherapie lamp gelegd. De lamp zorgt ervoor dat de bilirubine wordt afgebroken en via urine en ontlasting wordt uitgescheiden. De baby draagt een brilletje van stof om de ogen te beschermen tegen het felle licht.

Infuus: de meeste baby’s op de afdeling kunnen voeding en medicijnen via de maag en darmen (nog) niet goed opnemen. Zij krijgen dan calorierijk vocht via een infuus. Hiervoor wordt een infuusslangetje ingebracht in een klein bloedvat, in een arm, een been, via de navel, of met hoge uitzondering op het hoofd. In het laatste geval kan het nodig zijn om wat hoofdhaar weg te scheren.

Een **maagsonde** is een slangetje dat door de mond, of door de neus van de baby via de slokdarm naar de maag gaat. Hierdoor wordt een baby gevoed die zelf niet voldoende kan of mag drinken, maar wel in staat is voeding te verteren.

Onderzoeken

Om inzicht te krijgen en te houden in de lichamelijke conditie van de baby’s, wordt veel onderzoek gedaan. De meest voorkomende zijn:

- lichamelijk onderzoek
- laboratoriumonderzoek
- röntgenonderzoek en
- echo-onderzoek.

De uitslagen van de onderzoeken bespreekt de arts met u. Er kan een gehoortest worden afgenomen. Vooraf is niet altijd te voorzien wanneer een onderzoek plaats zal vinden.

Het kan ook zijn dat uw kind door de oogarts moet worden bekeken. De arts kan u vertellen of uw kind aan die criteria voldoet, wat het onderzoek van de oogarts inhoudt en waarom het plaatsvindt.

In Nederland wordt enkele dagen na de geboorte bij alle baby's een hielprik gedaan (PKU/CHT/AGS onderzoek). Het hielprikbloed wordt getest op ernstige, maar behandelbare aandoeningen. Voor deze test krijgt u bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis een witte envelop en een uitgebreide informatiefolder. Wilt u die envelop afgeven aan de verpleegkundige?

Ouders krijgen binnen 5 weken de uitslag van de PKU-test.

Verzorging door de ouders

Zoals eerder vermeld, is het voor u en uw baby belangrijk om een goede band te krijgen. Dit is ook een belangrijke reden om u zoveel mogelijk bij de verzorging te betrekken.

Verzorging en voedingstijden

Afhankelijk van het aantal voedingen dat uw baby krijgt, zijn de voedings-/verzorgingstijden:

- bij 8 keer: 2 uur, 5 uur, 8 uur, 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur, 20.00 uur en 23.00 uur of 3.00 uur, 6.00 uur, 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur, 21.00 uur, 24.00 uur.

U hoort van de verpleegkundige hoe laat uw kind eten krijgt.

- bij 12 keer: 1.30 uur, 3.30 uur, 5.30 uur, 7.30 uur, 9.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur, 15.30 uur, 17.30 uur, 19.30 uur, 21.30 uur. 23.30 uur.

Als u niet bij uw baby bent en u uw baby zelf wilt voeden, verzoeken wij u een half uur eerder aanwezig te zijn zodat u uw baby voor de voeding kunt (helpen) verzorgen.

Borstvoeding

Uw baby kan borstvoeding krijgen. Wanneer u borstvoeding wilt geven, is het raadzaam om zo snel mogelijk te beginnen met afkolven om de voeding op gang te brengen. Als een moeder bij de baby inroomt, krijgt zij de eerste 5 dagen een 24 uur set. Na de 5e dag krijgt de moeder een reusabel set die 1x per dag moet worden uitgekookt en die ook mee naar huis mag.

Op de derde etage bij de kant van het geboortehotel staat een kolfuitleenkast, hier kunt u een kolf huren, neem wel een bankpas mee om deze te huren.

In het begin hebt u nog weinig voeding, maar ook kleine beetjes dragen bij aan de gezondheid van uw baby. Als de baby nog niet sterk genoeg is om zelf te drinken, krijgt het de moedermelk via een sonde.

Op de afdeling zijn potjes aanwezig waarin de moedermelk bewaard kan worden. De moedermelk kan 48 uur in de koelkast en zelfs 3 tot 12 maanden in de vriezer bewaard worden. Ook kunt u stickers krijgen waar de naam van uw baby opstaat.

Noteer op ieder potje de naam van uw baby en datum en tijd van afkolven. Iedere keer dat u afkolft, gebruikt u een nieuw potje. Wanneer u thuis afkolft kunt u de potjes moedermelk het beste in aluminiumfolie verpakt in een koeltas naar het ziekenhuis meenemen.

Buidelen

Een eenvoudige manier om het lichamelijke contact met uw baby te versterken is buidelen. Hierbij komt uw baby, met een warme doek omgeslagen, bloot op de borst van de vader of moeder te liggen. Uw baby raakt hierdoor vertrouwd met uw stem en geur en voelt tevens uw hartslag en bewegingen. Dit heeft een positieve invloed op de ademhaling. De eerste keren dat u gaat buidelen begeleidt een verpleegkundige u hierbij. Gebruik vóór het buidelen geen parfum en rook niet van tevoren.

Voorzieningen voor de ouders

Medische indicatie baby

Het kan zijn dat uw baby na de geboorte in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Als u, als moeder, zelf geen medische indicatie heeft, kunt u toch bij uw baby op de kamer verblijven. Uw zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering tot en met 27 dagen na de geboorte van uw baby uw verblijf, inclusief alle maaltijden. Deze vergoeding gaat wel ten koste van uw **eigen risico**.

Na de eerder genoemde 27 dagen kunt u nog steeds bij uw kind blijven. Wij zetten uw verblijf dan om in ‘rooming in’. Dit betekent dat u als gast gratis kunt blijven overnachten bij uw kind. ’s Ochtends krijgt u wel een ontbijt, maar de andere maaltijden moet u zelf betalen. Vraagt u de verpleegkundige naar de folder ‘Rooming-in’.

Medische indicatie moeder

Het kan ook zijn dat u als gevolg van een medische indicatie na de bevalling samen met uw baby op de afdeling Verloskunde moet blijven. De verpleegkundigen van deze afdeling zorgen dan volledig voor u en uw baby.

Dagboek

De ervaring leert dat ouders het prettig vinden als tijdens het verblijf van hun baby een dagboek wordt bijgehouden. Als u een schriftje meeneemt kunnen daarin door u en desgewenst door ons de verschillende gebeurtenissen worden opgeschreven. Op de afdeling zijn folders en boeken over couveuse baby’s die u kunt inzien.

Ouderavonden

Elke tweede dinsdag van de maand wordt er een oudergespreksavond georganiseerd in samenwerking met Care4neo. Op deze avond kunnen ouders met elkaar praten, ervaringen delen en vragen stellen. Verpleegkundigen van de afdeling zijn hierbij aanwezig. U ontvangt van tevoren een uitnodiging voor deze avond.

Dienst Geestelijke verzorging

Opname van uw baby in het ziekenhuis kan een ingrijpende ervaring zijn die levensvragen en onzekerheden oproept. Als u hierover wilt praten met een geestelijk verzorger of als u uw hart eens wilt luchten, kan dat. In het ziekenhuis zijn een christelijk geestelijk verzorger, een moslim en een humanist werkzaam. Zij sluiten aan bij wat voor u belangrijk is. U kunt de arts of verpleegkundige vragen om contact met hen op te nemen.
Ook kunt u hen zelf bellen via telefoonnummer (070) 210 3835, iedere werkdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Uw eigen geestelijk verzorger (dominee, pastoor, imam, pandit, humanistisch raadgever et cetera) is uiteraard ook welkom op de afdeling.

Ontslag

Naar huis

Een paar dagen van tevoren hoort u wanneer uw baby naar huis mag, zodat u zich daarop kunt voorbereiden. Voor uw baby wordt ontslagen, vindt een gesprek met de arts en de verpleegkundige plaats. U hebt dan nog gelegenheid vragen te stellen. Zo nodig krijgt u een recept mee voor medicijnen voor uw baby.

Wij stellen het op prijs als u uw ervaringen deelt met de afdeling. Wij komen met een tablet langs om de opname te evalueren. Wij zouden het waarderen als u deze enquête invult.

Ontslag informatie vitamine D en K

- **Vitamine D** wordt gegeven voor sterke botten. Het starten met de druppels begint op de 8e dag na geboorte en stopt met het 4e jaar.*
  De voorkeur heeft om de vitamine druppels, los van de voeding, op een lepeltje of in de speen van de fles te geven. Dagelijks krijgt uw kind 10 microgram = 400IE. Op het flesje zelf staat altijd hoeveel druppels dit zijn, dit kan per merk verschillen.
- **Vitamine K** wordt gegeven voor een goede bloedstolling. De voorkeur heeft om de vitamine druppels, los van de voeding, op een lepeltje of in de speen van de fles te geven. Dagelijks krijgt uw kind 150 microgram. Op het flesje zelf staat altijd hoeveel druppels dit zijn, dit kan per merk verschillen.

Kunstvoeding
Indien uw kind alleen flesvoeding krijgt, hoeft er geen extra vitamine K te worden gegeven, de gift na geboorte is dan toereikend. In de flesvoeding zelf zit al genoeg vitamine K.

Combi kunst- en borstvoeding
Vitamine K wordt gestart op de 8ste dag na de geboorte. De vitamine K druppels kunnen gestopt worden, indien er meer dan 500ml van de dagelijkse voeding uit kunstvoeding bestaat.

Borstvoeding
Vitamine K wordt gestart op de 8ste dag na de geboorte. Het wordt gegeven tot en met de 3e levensmaand, tenzij eerder wordt overgegaan op kunstvoeding, dan geldt bovenstaande. Indien uw kind voor 35 weken geboren is, begint u pas met de 3 maanden tellen vanaf de 35e week.

**Het advies is dat kinderen met een donkere huidskleur hun hele leven vitamine D moeten blijven nemen omdat hun donkere*
huid ervoor zorgt dat het zonlicht minder wordt opgenomen.

Voor meer informatie gaat u naar het voedingscentrum en CJG Den Haag

Overplaatsing

Als het beter gaat met uw baby en hij of zij geen intensieve zorg meer nodig heeft, kan overplaatsing naar een andere verpleegafdeling nog nodig zijn. Dat kan naar Unit A of B in het Juliana Kinderziekenhuis zijn, naar het ziekenhuis waar de baby geboren is, of naar een ziekenhuis dichter bij u in de buurt. Wij hebben een folder over de overplaatsing. Als u dat wenst kunt u een rondleiding krijgen om de afdeling te zien.

De overplaatsing gaat uiteraard in overleg met u. Zodra bekend is naar welk ziekenhuis uw baby gaat, is het raadzaam vooraf een kijkje te nemen op de nieuwe afdeling als dat mogelijk is.

Vervroegd ontslag met sondevoeding

Het is mogelijk dat uw baby in de periode dat het sondevoeding heeft en het leert drinken naar huis mag. Hier is wel de voorwaarde aan verbonden dat uw baby thuis sondevoeding krijgt. Dit vervroegd ontslag heet: PREVOS. Dat staat voor PREmaturen met Vervroegd Ontslag met Sondevoeding.

De artsen en verpleegkundigen bekijken of uw baby voldoet aan de voorwaarden die aan dit vervroegd ontslag zijn verbonden. U als ouder bepaalt of u uw baby thuis sondevoeding kunt of wilt toedienen. Als u instemt met de voorwaarden voor het vervroegd ontslag, begeleidt een PREVOS-verpleegkundige u thuis.

De PREVOS-verpleegkundige belt u 2x per week op. Tijdens deze gesprekken begeleidt de verpleegkundige u bij het toedienen van de sondevoeding en geeft advies over het leren drinken van uw baby. Als uw baby volledig zelfstandig kan drinken, eindigt de begeleiding van de PREVOS-verpleegkundige. De Nazorgpoli of het consultatiebureau neemt de verdere begeleiding over.

Nazorgpoli Neonatologie of poliklinische controle

Controle vindt meestal plaats door één van de kinderartsen/neonatologen op de polikliniek van het Juliana Kinderziekenhuis. Deze bekijkt hoe lang en hoe vaak de controles noodzakelijk zijn en overlegt met u voor welke polikliniek uw baby hebt beste in aanmerking komt.

De Nazorgpoli Neonatologie is een speciale polikliniek waarbij een neonatoloog samen met de fysiotherapie, Consultatiebureau(arts/verpleegkundige) en eventueel de diëtiste uw baby vervolgt. De controles zijn voor baby's die te vroeg geboren zijn, een te laag geboortegewicht hebben of baby's die ernstige problemen hebben gehad. Op de Nazorgpoli worden de kinderen voor langere tijd gecontroleerd en gevolgd tot uiterlijk 4½ jaar. Als uw baby hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hier apart een folder over.

Wat u verder nog moet weten

Rechten en plichten

Als ouder van een kind hebt u rechten en plichten. Zoals het recht op informatie. Hulpverleners moeten duidelijke informatie geven over de ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan, maar ook over onderzoeken, behandelingen, mogelijke bijwerkingen en risico's. Verder heeft u recht op informatie over eventuele andere behandelmethoden. De arts mag alleen behandelen en onderzoeken als de ouders daarvoor toestemming geven.

U kunt ook om een mening van een tweede arts vragen: een second opinion. Van u verwachten we dat u de artsen en de verpleegkundigen zo volledig mogelijk informeert, zodat zij uw baby zo goed mogelijk kunnen behandelen.

Daarnaast is er het recht op privacy. Alles wat de behandeling van uw baby betreft, wordt beschreven in het medische dossier en het zorgdossier. U heeft recht op inzage hiervan. Verder mogen alleen de hulpverleners die uw baby verzorgen of behandelen de dossiers inzien. Het medisch dossier kunt u inzien in overleg met de arts. Aan anderen worden geen mededelingen gedaan over de

gezondheidstoestand van uw baby. Recht op privacy houdt ook in dat alléén met toestemming van u, anderen bij een onderzoek of ingreep aanwezig mogen zijn.

Privacyverklaring HagaZiekenhuis

In de Privacyverklaring van het HagaZiekenhuis vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorgverlening in het ziekenhuis en dat u een klacht heeft. Het helpt als u over uw klacht kunt praten. Probeer dit eerst met de betrokkene(n) in het ziekenhuis te bespreken. Wellicht is er een misverstand of is het probleem snel op te lossen. Lukt dit niet, of vindt u het moeilijk om zelf met de betrokkene(n) over uw klacht te praten, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het HagaZiekenhuis. Meer informatie en contactgegevens staan in de folder; Klachtenregeling'. Deze is op de Neonatologie afdeling beschikbaar.

Bereikbaarheid

Het Juliana Kinderziekenhuis is gevestigd aan het Els Borst-Eilersplein 275.
Plan van uw reis (per fiets, Openbaar Vervoer of de auto) of via reizen met het openbaar vervoer (OV).

Heeft u nog vragen?

Heeft u na thuiskomst nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Neonatologie via telefoonnummer (070) 210 7219. Uw vragen kunt u ook bespreken bij de Nazorgpoli Neonatologie of met de wijkverpleegkundige op het consultatiebureau.

Belangrijke telefoonnummers

- Juliana Kinderziekenhuis: (070) 210 0000
- Afdeling Neonatologie: (070) 210 7219

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

182104022025